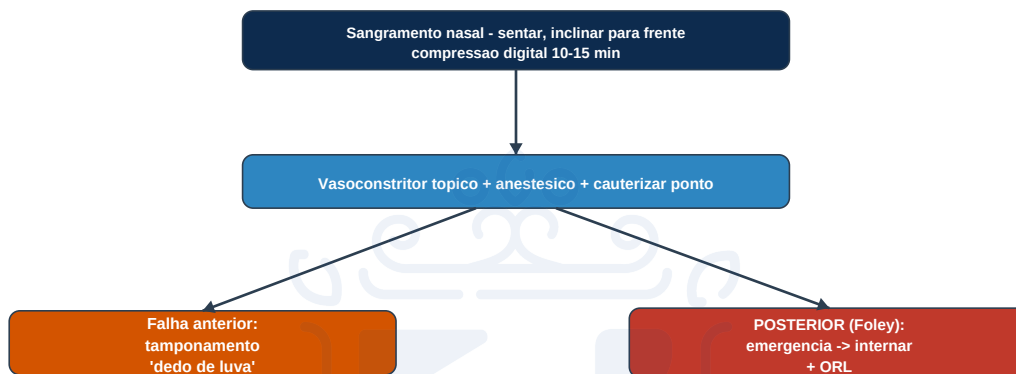


EPISTAXE — ANTERIOR x POSTERIOR

FLUXOGRAMA — MANEJO ESCALONADO

EPISTAXE — DA COMPRESSÃO AO TAMPONAMENTO



DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

O QUE É

- Sangramento de origem nasal, muito frequente no PS; gravidade variável
- ANTERIOR: plexo de Kiesselbach; visualização direta, geralmente unilateral e leve (maioria)
- POSTERIOR: artéria esfenopalatina; sangramento intenso, bilateral, sangue na orofaringe — potencialmente grave
- Exige abordagem sistematizada e escalonada

AValiação INICIAL

ANTES DE TUDO

- Avaliar estabilidade hemodinâmica e estimar o volume do sangramento
- Verificar uso de anticoagulantes/antiagregantes
- Identificar sinais de epistaxe POSTERIOR (sangue na orofaringe, bilateral, não cessa com compressão anterior)
- Investigar comorbidades (HAS, hepatopatia/coagulopatia)
- Controlar a PA elevada (a HAS perpetua o sangramento)

MANEJO PASSO A PASSO

Rx DA COMPRESSÃO À CAUTERIZAÇÃO

1. Sentar, tronco inclinado para frente; compressão digital da parte mole do nariz por 10-15 min; compressa fria no dorso
 2. Vasoconstritor tópico: Oximetazolina 2 jatos OU adrenalina 1:10.000 (1mL de 1:1.000 + 9mL SF) em algodão por 10 min (evitar em HAS grave não controlada)
 3. Anestésico tópico: Lidocaína 2% em algodão (facilita cauterização/tampouamento)
 4. Cauterização com nitrato de prata no ponto sangrante por 5-10s
- NÃO cauterizar AMBOS os lados do septo simultaneamente (risco de perfuração septal)

TAMPONAMENTO

Rx ANTERIOR ('dedo de luva')

Indicado: falha das medidas anteriores / sangramento anterior persistente
Cortar dedo de luva estéril; preencher com gaze (cilindro)
Lubrificar com lidocaína gel; introduzir no assoalho da fossa nasal
Ajustar até preencher a fossa; fixar externamente
Permanência: 24-48h

Rx POSTERIOR (sonda Foley)

EMERGÊNCIA: suspeita de epistaxe posterior -> internação + ORL
Foley nº 12-14, introduzir até ver na orofaringe
Insuflar o balão com 7-10 mL de SF; tracionar até acomodar na coana
Associar tamponamento anterior; fixar externamente
Monitorizar dor, saturação e risco de aspiração + analgesia

ANTIBIÓTICO E INTERNAÇÃO

QUANDO

- Profilaxia ATB se tamponamento > 24h: Amoxi-clav 875/125mg VO 12/12h por 5-7 dias (alergia: Clindamicina 300mg 6/6h)
- INTERNAR: epistaxe posterior, instabilidade hemodinâmica, necessidade de sonda Foley
- INTERNAR: uso de anticoagulante com sangramento ativo (avaliar reversão)
- Cuidado com o tamponamento posterior: risco de hipoventilação/aspiração (reflexo nasovagal)

ALTA E ORIENTAÇÕES

ALTA SE

- ☐ Sangramento controlado, sem sinais de epistaxe posterior
- ☐ Orientações fornecidas + retorno programado para retirada do tampão
- ☐ Não assoar o nariz por 48h; evitar esforço físico
- ☐ Hidratar a mucosa nasal com SF 0,9%
- ☐ Retornar se novo sangramento

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Epistaxe () anterior () posterior; estimativa de volume ____; anticoagulante: sim/não.
- Condutas: vasoconstritor + cauterização / tamponamento anterior / tamponamento posterior com Foley.
- Estabilidade hemodinâmica: ____; PA controlada: sim/não.
- Motivo da transferência: falha terapêutica / epistaxe posterior / avaliação cirúrgica (ORL).

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a primeira medida no manejo da epistaxe anterior no PS?

- A) Tamponamento posterior com sonda Foley
- B) Sentar o paciente inclinado para frente e fazer compressão digital da parte mole do nariz por 10-15 minutos
- C) Cauterizar ambos os lados do septo
- D) Inclinar a cabeça para trás
- E) Iniciar antibiótico endovenoso

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado sugere epistaxe POSTERIOR?

- A) Sangramento unilateral leve visível na narina
- B) Sangramento intenso, bilateral, com sangue escorrendo pela orofaringe e que não cessa com compressão anterior
- C) Sangramento que cessa com compressão digital
- D) Ponto sangrante no plexo de Kiesselbach
- E) Epistaxe após assoar o nariz, leve

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que não se deve cauterizar ambos os lados do septo nasal simultaneamente?

- A) Por dor excessiva
- B) Pelo risco de perfuração septal
- C) Porque é ineficaz
- D) Porque consome muito nitrato de prata
- E) Porque causa anosmia permanente

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Após tamponamento nasal por mais de 24h, qual conduta é recomendada?

- A) Nenhuma medida adicional
- B) Profilaxia antibiótica (amoxicilina-clavulanato)
- C) Corticoide oral
- D) Anticoagulação
- E) Retirar o tampão em 6 horas

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual cuidado é essencial após o tamponamento posterior com sonda Foley?

- A) Liberar o paciente imediatamente
- B) Internação com monitorização de dor, saturação e risco de aspiração
- C) Suspender analgesia
- D) Assoar o nariz com força
- E) Aplicar calor local

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A primeira medida na epistaxe anterior é posicionar o paciente sentado e inclinado para frente (evita deglutar sangue/aspiração) e comprimir a parte mole do nariz por 10-15 minutos — resolve a maioria dos casos.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Sangramento intenso, bilateral, com sangue na orofaringe e refratário à compressão anterior sugere epistaxe posterior (artéria esfenopalatina) — potencialmente grave, exige tamponamento posterior, internação e ORL.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A cauterização bilateral simultânea do septo deve ser evitada pelo risco de perfuração septal (isquemia da mucosa de ambos os lados no mesmo ponto).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Tamponamento nasal por > 24h indica profilaxia antibiótica (amoxicilina-clavulanato; clindamicina se alergia) para reduzir o risco de sinusite/síndrome do choque tóxico associado ao tampão.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O tamponamento posterior com Foley exige internação com monitorização de dor, saturação e risco de aspiração/hipoventilação (reflexo nasovagal), além de analgesia adequada.

SM24
Suporte ao Plantão Médico